

TEMA 3.14 • OBSTETRICIA

Causales de Aborto en Chile (Ley 21.030)

PERFIL EUNACOM 2.01.2.018

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Causales de Aborto en Chile (Ley 21.030)

Regla General

El aborto provocado en Chile es un **delito**, con **tres excepciones** (causales).

Las Tres Causales

TABLA 3.14.1: CAUSAL VS DESCRIPCIÓN		
CAUSAL	DESCRIPCIÓN	EJEMPLOS
1. Riesgo vital materno	Enfermedad que pone en peligro la vida de la madre	Cardiopatía congénita severa, preeclampsia severa < 22 sem, lupus eritematoso severo
2. Inviabilidad de vida extrauterina	Condición genética o adquirida que impide la sobrevivencia del feto fuera del útero	Trisomía 18, trisomía 13, anencefalia. NO trisomía 21 (síndrome de Down: viable)
3. Violación	Embarazo producto de violación	—

NOTA CLÍNICA

Si el feto ya es viable (> 22 semanas) y hay riesgo vital materno → **no se hace aborto**, se hace **interrupción del embarazo** intentando mantener al feto vivo también.

Aspectos Legales

Voluntariedad y consentimiento

- El aborto es **absolutamente voluntario** — no es obligatorio aunque se cumpla la causal - Se requiere **autorización escrita** de la paciente - El médico debe **informar** a la paciente sobre su derecho a realizarse el aborto

Edad gestacional

TABLA 3.14.2: CAUSAL VS LÍMITE DE EG	
CAUSAL	LÍMITE DE EG
Riesgo vital / inviabilidad	Sin límite (según viabilidad fetal)
Violación	Hasta 14 semanas (no 12)

Menores de edad

TABLA 3.14.3: EDAD VS REQUISITO	
EDAD	REQUISITO
< 18 años	Informar al representante legal; la menor decide
< 14 años	Autorización del representante legal (si niega → autorización judicial)

Derecho a Acompañamiento

La paciente tiene derecho a apoyo psicológico/psiquiátrico: - **Antes** de decidir (para tomar la decisión informada) - **Después** del procedimiento (riesgo de depresión, trastornos ansiosos)

Objeción de Conciencia

Definición: Derecho del médico a negarse a realizar abortos por convicciones personales/religiosas.

- **Requisitos:**
- Debe comunicarla **por escrito** y **previamente** (no en el momento de atención)
- Puede objetar **una, dos o las tres** causales (no necesariamente todas)
- La más objetada en la práctica: **causal violación** (la causal de riesgo vital e inviabilidad tienen menor tasa de objeción)
- **Obligaciones del médico objetor:**
- Derivar a otro médico dentro del mismo establecimiento
- Si todo el establecimiento es objetor → derivar a otro centro asistencial
- **Excepción a la objeción:**
- **Riesgo materno inmediato** → el médico objetor DEBE actuar (o la madre morirá)

Objeción institucional

Aplica a instituciones (ej. hospitales católicos). Misma lógica: deben derivar a donde sí se realice el procedimiento.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Causales de Aborto en Chile (Ley 21.030): Riesgo vital materno | Enfermedad que pone en peligro la vida de la madre | Card... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Causales de Aborto en Chile (Ley 21.030). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Regla General
- Las Tres Causales
- Aspectos Legales
- Voluntariedad y consentimiento
- Edad gestacional
- Menores de edad
- Derecho a Acompañamiento

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CAUSALES DE ABORTO EN CHILE (LEY 21.030))

PREGUNTA 1

En relación a Causales de Aborto en Chile (Ley 21.030): Riesgo vital materno | Enfermedad que pone en peligro la vida de la madre | Card... ¿cuál es la conducta correcta?

- ☐ A) El diagnóstico de Causales de Aborto en Chile (Ley 21.030) se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- ☐ B) El manejo inicial de Causales de Aborto en Chile (Ley 21.030) debe orientarse según el estado clínico del paciente
- ☐ C) Todo paciente con Causales de Aborto en Chile (Ley 21.030) requiere hospitalización inmediata
- ☐ D) El tratamiento de Causales de Aborto en Chile (Ley 21.030) es igual en todas las edades y contextos clínicos
- ☐ E) El seguimiento de Causales de Aborto en Chile (Ley 21.030) no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Causales de Aborto en Chile (Ley 21.030)?

- ☐ A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- ☐ B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- ☐ C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- ☐ D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- ☐ E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Causales de Aborto en Chile (Ley 21.030). Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- ☐ A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- ☐ B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- ☐ C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- ☐ D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- ☐ E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: CAUSALES DE ABORTO EN CHILE (LEY 21.030)

:::note Si el feto ya es viable (> 22 semanas) y hay riesgo vital materno → no se hace aborto, se hace interrupción del embarazo intentando mantener al feto vivo también. ::: Aplica a instituciones (ej. hospitales católicos). Misma lógica: deben derivar a donde sí se realice el procedimiento.